

Περίπτωση 34η

Γυναίκα 32 ετών, εγκυμονούσα, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με ταχύπνοια, αδυναμία, ζάλη και επανειλημμένα επεισόδια εμέτων.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 63 mmHg
- PCO₂ = 30 mmHg
- pH = 7.63
- [HCO₃⁻] = 31 mEq/L
- [Na⁺]_{ούρων} = 10 mEq/L
- [K⁺]_{ούρων} = 22 mEq/L
- [Cl⁻]_{ούρων} = 09 mEq/L
- [Na⁺] = 139 mEq/L
- [K⁺] = 3.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 94 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 106 mg/dl
- [Ουρίας] = 35 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

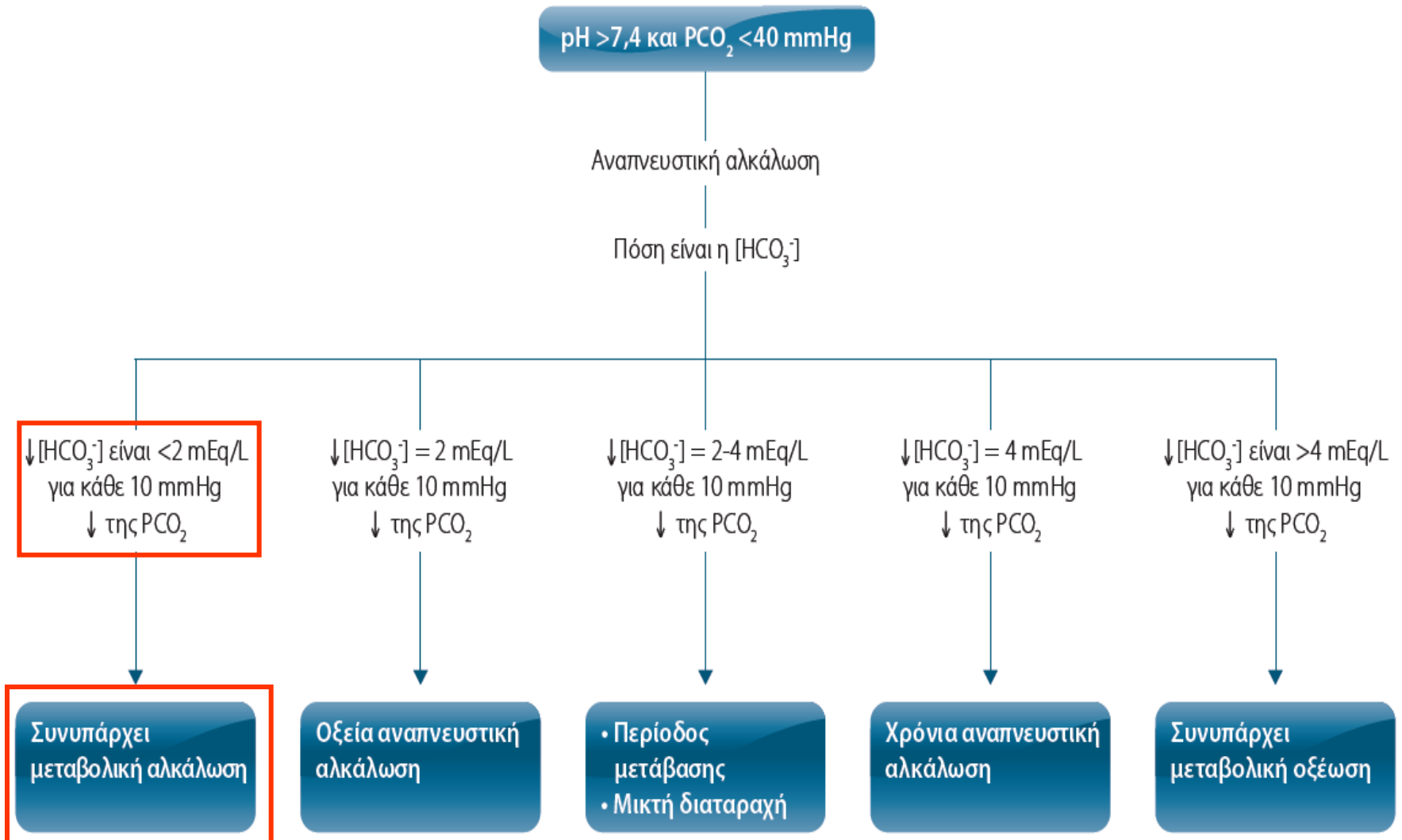
- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.63 (> 7.40)
- PCO₂ = 30 mEq/L (< 40 mmHg)
- **Αναπνευστική αλκάλωση (κύρια διαταραχή)**

Η αναπνευστική αλκάλωση είναι οξεία ή χρόνια;
Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 31 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 7 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 30 \text{ mmHg}$, $\downarrow$ κατά 10 mmHg
- Η $[\text{HCO}_3^-]$ αντί για μειωμένη είναι **αυξημένη**
- **Αναπνευστική αλκάλωση + Μεταβολική αλκάλωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



- Η αναπνευστική αλκάλωση οφείλεται στον υπεραερισμό λόγω εγκυμοσύνης
- Η ασθενής έχει μεταβολική αλκάλωση με ↓ εξωκυττάριο όγκο και αφού $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 10 \text{ mEq/L}$ και $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 09 \text{ mEq/L}$, η ↓ του εξωκυττάριου όγκου οφείλεται στην απώλεια γαστρικών υγρών λόγω εμέτων

- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει αναπνευστική αλκάλωση λόγω υπεραερισμού συνεπεία εγκυμοσύνης και μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με μειωμένη $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$) συνεπεία επανειλημμένων επεισοδίων εμέτων

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση